SLEEP-06 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

שימור ובירור קושי מתמשך

1 | מטרה, התאמה וגבולות

מטרת היחידה

לסכם אילו התאמות מועילות, לבחור תיעוד מועט אם הוא נחוץ, ולהכין שאלות לבירור קושי שנמשך. המשך הסדרה נקבע לפי צורך והערכה, ולא לפי חובה להשלים שישה שלבים.

בחירה והתאמה

בחרו בדף לאחר הערכה מקצועית ובהסכמה. אפשר לדלג, להשיב בעל פה או לבחור כלי אחר. זהו חומר מקורי מוצע לסקירה; אין ציון, אבחון או הבטחה לתוצאה.

גבולות ייחודיים ליחידה

זה אינו פרוטוקול CBT-I מלא, כלי אבחון או תנאי לפנייה לרופא. אין לצמצם זמן שינה, לשנות טיפול או להמתין לסיום מעקב כשנדרש בירור. מעקב שמגביר לחץ או בדיקות חוזרות מופסק ונבחן מחדש.

שימוש חוזר בחומר הקיים

סכמו רק מידע שימושי מ־SLEEP-01–05. אין צורך למלא שוב את כל הדפים; הערכה רפואית ותוכנית טיפול ייעודית נשארות באחריות הגורם המתאים.

דוגמה בדויה לשיחה

דוגמה בדויה: דוד מוצא שהתאמת הרעש נעימה, אך עדיין נרדם בלי כוונה ביום. הוא מכין עם המטפל תיאור קצר ושאלות לרופא, ואינו ממתין להשלמת כל דפי הסדרה.

> טיוטה לסקירת מנהל. סקירה קלינית ואישור זכויות סופיים טרם הושלמו.

Mindful Path

SLEEP-06 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

לעבוד יחד עם דף העבודה

2 | שיחה סביב מצב אחד

פתיחה

בחרו מצב שהאדם מעוניין לבדוק. אין צורך לבחור את המצב הקשה ביותר. ודאו שהשאלה מובנת ושהמילים מתאימות לאדם; תיאורו קודם לפרשנות המטפל.

1 | שאלה לשיחה

מה למדתי על התאמות, מגבלות ותמיכה?

2 | שאלה לשיחה

אילו קשיים מתמשכים או שינויים חשוב לתאר?

3 | שאלה לשיחה

מהו המידע המצומצם הנחוץ לבירור המתוכנן?

4 | שאלה לשיחה

אילו שאלות אציג לגורם המקצועי המתאים?

5 | שאלה לשיחה

מה יישאר גמיש עד שתתקבל הערכה נוספת?

סיום

סכמו מה הובן ומה נשאר פתוח. היעזרו ב־SES-S01 וב־SES-S02 הקיימים למעטפת המפגש. אין צורך למלא שוב הערכה או תוכנית שכבר תועדה.

קשיים אפשריים

כאשר תיעוד הופך לבדיקה מתמדת, הפסיקו אותו. אם קשה לפנות לשירות מתאים, בררו חסמי נגישות וסיוע מעשי במקום להציע עוד מעקב.

Mindful Path

SLEEP-06 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

התאמה לארבע קבוצות גיל

3 | גיל הוא נקודת מוצא, לא הנחה על יכולת

CH | ילדים, בקירוב 6 עד 11

מבוגר מנהל פנייה ובירור רפואי, והילד מוסר תיאור במילים שלו. אין לתת לילד משימת מעקב לילית או אחריות לזימון עזרה.

הציעו שאלה אחת בכל פעם ומעט כתיבה. תיווך מבוגר לא יחליף את קול הילד.

TE | מתבגרים, בקירוב 12 עד 17

סכמו מה המתבגר רוצה לתאר בעצמו ומה ייאמר עם מבוגר. פרטיות אינה הבטחה להסתיר מידע הנדרש לבטיחותו.

סכמו מראש מה משתפים ועם מי, ואת גבולות הפרטיות במסגרת. אין להבטיח סודיות מוחלטת.

AD | מבוגרים

אפשר להכין שאלות על תפקוד, תנאים ודרכי בירור בלי להסיק אבחנה. מידע תרופתי מועבר לגורם מטפל; שינוי טיפול אינו חלק מהדף.

OA | מבוגרים יותר

אפשר להביא סיכום בעל פה במקום יומן. מלווה מסייע לפי בחירה ואינו מחליף את תיאור האדם או את הסכמתו.

אפשר להציע קריאה, זמן ושיחה לפי העדפה. סיוע מאדם אחר ייבחר עם המשתתף ובהתאם לפרטיותו.

> נדרשת סקירה נפרדת לכל גרסת גיל. אישור לגרסה אחת אינו אישור אוטומטי לאחרות.

Mindful Path

Mindful Path

SLEEP-06 | מטפל בלבד - כל קבוצות הגיל

תרגול, סקירה והמשך

4 | בחירה משותפת ולמידה מהניסיון

לפני מסירת דף P

אם נבחר תיעוד, קבעו מראש מידע מועט ונקודת סיום עם המטפל. אפשר להכין שאלה אחת בלבד; אין חובת יומן או צורך להשלים אותו לפני בקשת עזרה.

במפגש הבא

סכמו מה מועיל ומה דורש בירור נוסף. אין הכרזה שהקושי נפתר רק משום שהסדרה הסתיימה, ואין צורך להמשיך דפים שאינם משרתים את האדם.

תיעוד מקצועי וטכני

קיימת רשומת סקירה נפרדת לכל גרסה: התאמת גיל, מקוריות, זכויות ומילוי בדוי. סוקר ותאריך שטרם נקבעו נשארים ריקים. בדיקת קבצים או מיזוג קוד אינם אישור קליני. מידע טיפולי נשמר רק במסגרת המורשית, מחוץ למאגר הקוד.

מקורות עיון

הקישורים הבאים שימשו לרקע בלבד. השאלות וההתאמות נכתבו מחדש לפי תוכנית ההרחבה; לא הועתק שאלון, מדד או פרוטוקול. מקורות למבוגרים אינם מתקפים את גרסאות הילדים. אין בחומר זה קביעה של מספר מפגשים או יעילות טיפולית.

www.nhs.uk/conditions/insomnia/
www.nhs.uk/conditions/excessive-daytime-sleepiness-hypersomnia/

Mindful Path